

RAPPORT DE SYNTHESE CLINIQUE & BIOLOGIQUE

Genre :	Féminin	Motif :	Douleurs abdominales, nausées, vomissements
Age :	34 ans	Antecedents :	Non précisé dans le rapport
Etat des Alertes :	4 CRITIQUE(S) / 5 anomalie(s)		

Analyses biologiques detaillees

Parametre	Valeur	Unite	Normes	Statut	Risque Clinique
Hémoglobine	8.4	g/dL	12.0-16.0	ANORMAL	Anémie sévère - risque d'insuffisance ...
Plaquettes	44.0	G/L	150-400	CRITIQUE	Thrombopénie sévère - risque hémorragi...
Leucocytes (GB)	18.6	G/L	4.0-10.0	ANORMAL	Hyperleucocytose - possible leucémie o...
Glycémie (à jeun)	24.7	mmol/L	3.9-6.1	ANORMAL	Hyperglycémie majeure - acidocétose ou...
Potassium (Kaliémie)	3.1	mmol/L	3.5-5.0	ANORMAL	Hypokaliémie sévère - arythmie cardiaq...
Lipase	640.0	U/L	0-160	CRITIQUE	Pancréatite aiguë sévère
Fibrinogène	0.9	g/L	2.0-4.0	CRITIQUE	Hypofibrinogénémie - CIVD ou insuffisa...
TSH (Thyréostimuline)	0.08	mUI/L	0.4-4.0	CRITIQUE	Hyperthyroïdie - crise thyrotoxique po...
Troponine I	0.02	ug/L	0-0.04	NORMAL	Normal
pH artériel	7.28		7.35-7.45	ANORMAL	Acidose sévère - défaillance multivisc...

Synthese Clinique & Actions suggerees

PATIENT OVERVIEW
Patient de 34 ans, Sexe : F. Motif d'admission : Douleurs abdominales, nausées, vomissements.
KEY FINDINGS
? Plaquettes: 44.0 G/L (normal: 150-400) ? Thrombopénie sévère - risque hémorragique spontané [CRITIQUE ?]
? Lipase: 640.0 U/L (normal: 0-160) ? Pancréatite aiguë sévère [CRITIQUE ?]
? Fibrinogène: 0.9 g/L (normal: 2.0-4.0) ? Hypofibrinogénémie - CIVD ou insuffisance hépatique sévère [CRITIQUE ?]
? TSH (Thyréostimuline): 0.08 mUI/L (normal: 0.4-4.0) ? Hyperthyroïdie - crise thyrotoxique possible [CRITIQUE ?]
? Hémoglobine: 8.4 g/dL (normal: 12.0-16.0) [ANORMAL ?]
? Leucocytes (GB): 18.6 G/L (normal: 4.0-10.0) [ANORMAL ?]
? Glycémie (à jeun): 24.7 mmol/L (normal: 3.9-6.1) [ANORMAL ?]
? Potassium (Kaliémie): 3.1 mmol/L (normal: 3.5-5.0) [ANORMAL ?]
? pH artériel: 7.28 (normal: 7.35-7.45) [ANORMAL ?]
CRITICAL ALERTS ?
? Plaquettes: 44.0 G/L (normal: 150-400) ? Thrombopénie sévère - risque hémorragique spontané
? Lipase: 640.0 U/L (normal: 0-160) ? Pancréatite aiguë sévère
? Fibrinogène: 0.9 g/L (normal: 2.0-4.0) ? Hypofibrinogénémie - CIVD ou insuffisance hépatique sévère
? TSH (Thyréostimuline): 0.08 mUI/L (normal: 0.4-4.0) ? Hyperthyroïdie - crise thyrotoxique possible
RECOMMENDED ACTIONS

- ? [HIGH] Plaquettes: Transfusion de plaquettes en urgence et évitement de toute injection intramusculaire ou traumatisme.
- ? [HIGH] Lipase: Avis médical spécialisé immédiat pour lipase critique (640.0) : Pancréatite aiguë sévère.
- ? [HIGH] Fibrinogène: Avis médical spécialisé immédiat pour fibrinogène critique (0.9) : Hypofibrinogénémie - CIVD ou insuffisance hépatique sévère.
- ? [HIGH] TSH (Thyréostimuline): Réactiver : Préserver le TSH au-dessus des valeurs normales pour éviter une crise thyrotoxique.
- ? [MEDIUM] Hémoglobine: Contrôle biologique de hémoglobine à distance et surveillance de l'état clinique du patient.
- ? [MEDIUM] Leucocytes (GB): Recherche active de foyer infectieux, prélèvements bactériologiques et surveillance thermique.
- ? [MEDIUM] Glycémie (à jeun): Contrôle biologique de glycémie (à jeun) à distance et surveillance de l'état clinique du patient.
- ? [MEDIUM] Potassium (Kaliémie): Contrôle biologique de potassium (kaliémie) à distance et surveillance de l'état clinique du patient.
- ? [MEDIUM] pH artériel: Réactiver: Réinforcer le surveillance continu et préparer le patient pour une intervention chirurgicale si le flux cérébrospinaux se révèle.